

TEMA 5.19 • OFTALMOLOGÍA

neurooftalmología 1

PERFIL EUNACOM 1.01.1.015

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Retinopatía Hipertensiva

Es el daño macro y micro vascular progresivo del fondo de ojo producto de una **Hipertensión Arterial** mal controlada o de larga data. Es de vital importancia en medicina general, ya que es el marcador in vivo más fácilmente accesible para evaluar y predecir directamente el nivel de injuria arterial y "**Daño a Órganos Blanco**" que el paciente está sufriendo en todo su sistema cardiovascular profundo y silencioso (Cerebrovascular y enfermedad renal parenquimatosa).

- **Clínica Asintomática inicial pura EUNACOM:** El mayor y profundo sello de la patología es que transcurre abrumadoramente **Silente e indetectable por el paciente (No relata pérdida de agudeza visual natural ni dolor algun)** sino hasta estadios finalísimos devastadores generales de isquemia perimetrales.

Hallazgos Clásicos Patognomónicos en Fondo de Ojo Clínicos

La patogénesis vascular se produce debido al grueso remodelamiento patológico, y al indurado estiramiento de presión de la capa arterio-hialina gruesa que obliga un tortuoso engrosamiento de los perfiles e infartos perimetrales, se evidenciarán ordenadas y cronológicamente general:

- **Alteración y Endurecimiento notable en los Cruces Arteriovenosos formales naturales (Clásico signo de preeminencia EUNACOM base):** Las arterias y venas que decantan irrigantes en cruces topológicos en el lecho retiniano suelen correr en cruces naturales limpios y asintomáticos, pero de forma y por culpa obligada intrínsecamente a nivel base macro al estar revestidas orgánicamente conjuntas biológicamente base y forzosamente encapsuladas por el forro estructural rígido perimetral de la Túnica Adventicia fibrosa ocular general basal, ocurre que la rígida arteria tónica engrosada y reactiva traccione bruscamente en cada pulso de presión arterial oprimiendo la vena subyacente del cruce y demarcándola.
- **"Hilo de Cobre" natural oftalmológico grueso:** Debido al esclerosado progresivo sostenido general, el normal reflejo vascular pálido de una arteriola delgada saludable al paso oftalmoscópico rebota un color endurecido macizo o amarillento cobrizo.
- **"Hilo de Plata" isquémico puro limitante y terminal posterior:** Estadio fibrótico atrofico superior de engrosamiento isquémico hialino rígido por esclerosis pura total arterial carente general en donde el vaso limitante del ojo se oblitera biológicamente en su lumen y refleja destello gris metálico macizo y plateado a luz por hiperplasia letal maciza general del endotelio con la muscular basal terminal obliterante general perimetral inespecífico de cronicidad tardía total atrofica final inerte general vascular muerta.
- ##### Signos Inespecíficos Compartidos
- Existen otros exudados retinales compartidos también por otras comorbilidades (**Retinopatía Diabética**, Trombosis, etc):
- **Micro-Hemorragias y Hemorragias Focalizadas Estriadas patognomónicas base ("Hemorragias en Llama"):** Patognomónicas generalizadas base para la severidad hipertensiva biótica pura general oftalmológica, originadas por explosión rotura focal de la íntima y diseminadas siguiendo linealmente la de las fibras nerviosas axónicas bióticas limitantes de la retina capilar basal. (Al unísono de TVCR general ocular vascular de presión basal reactiva).

- Microaneurismas focales crónicos débiles inespecíficos redondos y los infartos letales blancos distales algodanosos de isquemias focales exudados neurales axoplasmic paralelos blancos (Exudados Algodonosos de microinfarto grave general isquémico macizo capilar muerto por obstrucción de base patológica).

Diagnóstico, Pronóstico y Tratamiento Sistémico Biótico

- El diagnóstico limitante es directo biológicamente apoyado ineludible e incuestionable con uso simple rutinario general APS base ambulatorio natural preventivo focalizado a través del gran nivel semiológico **Fondo de Ojo tradicional**.
- Presenciar fuertemente exacerbación natural aguda extrema basal en edema puro masivo bilateral inflamatorio terminal inespecífico engrosando ambos discos bióticos (Edemas Focales y Papiledema Isquémico base masivo algodonomoso en toda su extensión crasa global) sumado bióticamente a signos vitales arteriales sistémicos elevados estallando base perimetrales indica en pabellón una **Emergencia Hipertensiva Maligna base**.
- Su tratamiento general absoluto no interviene en ningún caso la retina ni las alteraciones estructurales anatómicas oftálmicas focales en si mismas, el manejo biológico es siempre de índole netamente Médico general y farmacológico focalizado para apaciguar y disminuir drásticamente en meta las cifras crónicamente generalizadas bases descompensantes y tensionales en las dianas endógenas vasculares bases de **Manejo Estricto Sistémico Anti-Hipertensivo General** por el nefrólogo o internista del sistema de salud central APS para el sujeto.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un paciente de cuarenta años consulta por disminución del campo visual. Al realizar la campimetría se encuentra una hemianopsia temporal en el ojo derecho y una hemianopsia temporal en el ojo izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la causa más frecuente?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para neurooftalmología 1. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La parte medial o nasal del nervio óptico decusa en el quiasma; la lateral o temporal no decusa y continúa ipsilateral.
- Lesión del nervio óptico produce amaurosis ipsilateral total de ese ojo.
- Lesión del quiasma produce hemianopsia bitemporal, característica de los tumores de la hipófisis.
- Lesiones retroquiasmáticas como cintilla, radiaciones ópticas y corteza occipital producen hemianopsia homónima contralateral.
- La congruencia de la hemianopsia indica proximidad al lóbulo occipital: más congruente implica lesión más posterior.
- En la práctica clínica siempre se realiza resonancia magnética de cerebro para identificar la causa y ubicación de la lesión.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (NEUROFTALMOLOGÍA 1)**PREGUNTA 1**

Un paciente de cuarenta años consulta por disminución del campo visual. Al realizar la campimetría se encuentra una hemianopsia temporal en el ojo derecho y una hemianopsia temporal en el ojo izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la causa más frecuente?

- A)** Hemianopsia homónima derecha por lesión de la cintilla óptica izquierda
- B)** Hemianopsia bitemporal por lesión del quiasma óptico; causa más frecuente es tumor hipofisario
- C)** Amaurosis bilateral por lesiones de ambos nervios ópticos
- D)** Hemianopsia bitemporal por lesión de ambos lóbulos occipitales
- E)** Cuadrantopsia homónima inferior derecha por lesión de la radiación óptica superior

PREGUNTA 2

Un paciente presenta pérdida visual del ojo izquierdo completa, sin visión de ningún punto del campo visual de ese ojo. El ojo derecho es normal. ¿A qué nivel de la vía visual corresponde esta lesión?

- A)** Lesión del quiasma óptico
- B)** Lesión de la cintilla óptica izquierda
- C)** Lesión del nervio óptico izquierdo
- D)** Lesión del lóbulo occipital izquierdo
- E)** Lesión de la radiación óptica izquierda

PREGUNTA 3

Un paciente tiene una hemianopsia homónima derecha. La campimetría muestra que el defecto es exactamente simétrico en el ojo derecho e izquierdo, es decir, es altamente congruente. ¿Qué indica esta congruencia respecto a la ubicación de la lesión?

- A)** La lesión está en el quiasma óptico, porque la congruencia indica lesión anterior
- B)** La lesión está en la cintilla óptica, porque las lesiones anteriores son más congruentes
- C)** La lesión está cerca del lóbulo occipital, porque mayor congruencia indica lesión más posterior
- D)** La congruencia no tiene relación con la ubicación de la lesión en la vía visual
- E)** La lesión está en el nervio óptico derecho por la afectación del campo visual derecho

RESUMEN: NEUROFTALMOLOGÍA 1

La neuroftalmología es la rama que estudia las manifestaciones oculares de las enfermedades neurológicas. Esta primera clase aborda las lesiones de la vía visual y cómo cada punto de lesión produce un déficit visual específico y reconocible. La vía visual va desde la retina, pasa por el nervio óptico, llega al quiasma óptico donde ocurre la decusación de las fibras nasales, continúa por la cinta óptica o tracto óptico, sigue por las radiaciones ópticas y termina en el lóbulo occipital que es la corteza visual. Un concepto clave es la decusación quiasmática: la parte medial o nasal del nervio óptico, que recibe información de la retina nasal que ve el campo visual temporal, es la que decusa en el quiasma. La parte lateral o temporal del nervio, que ve el campo visual nasal, no decusa y continúa ipsilateral. Esto produce que las lesiones quiasmáticas afecten los campos visuales temporales de ambos ojos, produciendo la hemianopsia bitemporal característica. Las lesiones en cada punto producen: lesión del nervio óptico produce amaurosis ipsilateral total. Lesión del quiasma produce hemianopsia bitemporal, característica de los tumores hipofisarios. Lesiones retroquiasmáticas, de la cintilla óptica, las radiaciones o el lóbulo occipital, producen hemianopsias homónimas contralaterales. La congruencia de la hemianopsia indica la proximidad de la lesión al lóbulo occipital: más congruente es más posterior. En la práctica siempre se hace resonancia magnética de cerebro para identificar la lesión.